



Smøla kommune

– øy i et hav av muligheter

**Plan
for
helsemessig og sosial beredskap
for
Smøla Kommune
2026**

Utarbeidet september 2025, Matthias Steffen Schulz, kommuneoverlege

Vedtak i livsløpsutvalg xxxxx

Vedtatt i planutvalget xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vedtatt i formannskapet xxx

Vedtatt i Kommunestyret xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Innholdsfortegnelse

1. Administrativ del.....	4 -
1.1.Generelt.....	4 -
1.1.1.Kommunikasjon	4 -
1.1.2.Kommunal helseberedskap	4 -
1.1.3.regional og nasjonal helseberedskap	6 -
1.2.Lovgrunnlaget	7 -
1.2.1. Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)	7 -
1.2.2. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)	7 -
1.2.3. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) ..	7 -
1.2.4. Akuttmedisinforskriften	7 -
1.2.5. Folkehelseloven	8 -
1.2.6. relevante Stortingsmeldinger	8 -
1.3.Definisjoner og prinsipper	9 -
1.3.1Viktige definisjoner	9 -
1.3.1.1. Ordinær situasjon	9 -
1.3.1.2. Ekstraordinær situasjon	9 -
1.3.1.3. Katastrofe	9 -
1.3.1.4. Krig eller krigsfare	9 -
1.3.1.5. Ulykker	9 -
1.3.1.6. Kriser	9 -
1.3.1.7. Katastrofer	10 -
1.3.1.8. Melding.....	10 -
1.3.2. overordnede prinsipper.....	11 -
1.4.Sentrale aktører	11 -
2. Operativ del.....	13 -
Hoved prosedyrer ved kriser.....	13 -
2.1.Varsling	13 -
2.2 Mobilisering av ressurser	14 -
2.3.Prioritering og behandling	15 -
2.4. Transport av pasienter	17 -
2.5.Pårørende og psykososial krisehjelp	18 -
2.6.Debrifing/normalisering.....	18 -
3.Tiltakskort.....	19 -
3.1.Brann – helsesenter / sykeheim	19 -

3.2.Brann – omsorgsboliger / Hopen bofellesskap	- 19 -
3.3.Evakuering.....	- 19 -
3.4.CBRNE – kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktivitet og smittestoffer	- 20 -
3.5.Ammoniakkutslipp	- 20 -
3.6.Mobil/internett/nødsamband feil	- 20 -
3.7.Strømsstans	- 21 -
3.8.Psykisk krise	- 21 -
3.9.Ekstremvær	- 22 -
3.10.Smittespredning.....	- 22 -
3.11.Pandemi	- 23 -
3.12.Sosial beredskap.....	- 23 -
3.13.Kriseledelse	- 24 -
3.14.Kompetanse, opplæring og øvelser	- 25 -
3.15.Evaluering.....	- 25 -

Innledning

Plan for helsemessig og sosial beredskap er et underplan til Smøla kommunes overordnede beredskapsplan med hjemmel i [Lov om helsemessig og sosial beredskap §2.2.](#) og følger føringer i [Nasjonal helseberedskapsplan.](#)

Formålet med planen er å sikre at kommunens helse- og sosialtjeneste hurtig og effektivt kan makte en omstilling ved akutte og ekstraordinære situasjoner for å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp og sosialtjenester kan tilbys.

Planen tar derfor sikte på å gi nødvendige instruksjoner for raskt å kunne mobilisere personell og materiell i kommunens helsetjeneste ved større ulykker enn det den daglige beredskapen (legevakt/ambulansetjeneste) kan håndtere. Sanitets- og helsetjenester er ved større ulykker/katastrofer underordnet Innsatsleder (IL) som normalt vil være en polititjenestemann. Brann- eller helsepersonell kan fungere som skadestedsleder inntil politiet ankommer. Ved større kriser/katastrofer skal den kommunale kriseledelsen varsles (Se overordnet beredskapsplan med plan for kommunal kriseledelse).

Planen er tredelt.

- Administrativ del beskriver viktige regionale forhold av beredskapsmessig betydning, relevante definisjoner, overordnede prosedyrer og underliggende prinsipper og relevante aktører.
- Operativ del beskriver hovedprinsipper ved krise- og skadestedsarbeid
- Tiltakskort gir konkrete føringer ved definerte hendelser

1. Administrativ del

1.1. Generelt

Smøla er den nordligste kommunen i Møre og Romsdal og ligger ca. tre mil nord for Kristiansund. Over Ramsøyfjorden i øst ligger øykommunen Hitra, og over Edøyfjorden i sør Aure Kommune. Smøla Kommune er på 274,0 km² og har litt i underkant av 2200 innbyggere. Smøla kommune består av en stor øy (fast-Smøla) og mer enn 5000 mindre øyer, holmer og skjær, noe som gjør at kommunen har hele 1/3 av fylkets totale kystlinje. Flere øyer var tidligere bebodd, men blir nå i økende grad brukt som fritidseiendommer. Kjente er spesielt Brattværet, Hallarøya og Ringsøya. Helt sør i kommunen ligger Edøya som er knutepunkt for Kystekspresen og fergeforbindelse til fastlandet. Lengst nord i kommunen ligger det kjente fiskeværer Veiholmen. Høyeste punkt på hovedøya er Nelvikberget med 63 meter over havet. Landskapet ellers er relativt flatt, og kan betegnes som prærieaktig. Kommunesenteret er lokalisert på Hopen. Her finnes kommuneadministrasjon, lokalt NAV kontor, lensmannskontor og butikksenter. Smøla helsesenter og sykehjemmet er lokalisert på Innsmøla. De viktigste næringsveiene er fiske, fiskeoppdrett, jordbruk, turisme og noe mekanisk industri. Det er de siste åra blitt reist en stor vindpark med til sammen 68 vindmøller. Disse produserer elektrisk strøm i størrelsen 1 TW.

1.1.1. Kommunikasjon

Kommunen har ikke fastlandsforbindelse, men har bruer som forbinder Veiholmen, Kuli og Edøy til hovedøya. Kommunens fergeleie er på Edøya, hvor det er ankomst for bilferga fra Sandvika i Aure Kommune. Edøya anløpes også av Kystekspresen, som går i rute mellom Kristiansund og Trondheim flere ganger daglig. Fra Kristiansund tar det vel halvannen time med bil og ferge til Smøla. Kystekspresen bruker 35 minutter fra Kristiansund. Fra Trondheim til Smøla tar turen rundt 2,5 timer.

På Smøla er det stasjonert ambulanse- og legeskyss-båt "Mørejenta" betjent av båtfører og motormann, og bemannet med en ambulansearbeider/paramedic. Båten har en godt utstyrt legelugar og har et stort fartspotensial. Den brukes også til legeskyss og ambulanseoppdrag for Aure og tidligere Halså Kommune

1.1.2. Kommunal helseberedskap

Å opprettholde helsemessig beredskap i Smøla kommune er utfordrende blant annet på grunn av følgende forhold:

- Smøla er en øykommune med om lag 78 km reisevei fra Edøy til SNR på Hjelset.
- Utrykningstiden til beboere på øyene og holmene rundt kan overstige 30 minutter.
- Kommunen er svært værutsatt, noe som kan føre til stengte veier og utfordringer for både helikopter- og båttransport.
- Helsetjenesten er dimensjonert for ca. 2200 innbyggere, men på grunn av økende turisme er antallet personer i kommunen ofte betydelig høyere.

- Det er som regel kun én til to leger tilgjengelig i kommunen samtidig. Utenom kontortid inngår Smøla i et interkommunalt legevaktsamarbeid med Aure og Halså, med responstid mellom kommunene på 30–60 minutter.
- Det er én ambulansabil stasjonert på Dyrnes, en døgnbil bemannet kontinuerlig med to ansatte.

I arbeidet med beredskapsplanen fokuseres det på håndtering av følgende typer hendelser:

- trafikkulykker
- brann ved helsesenteret og trygdeboligene
- øvrige branner
- ekstremvær
- langvarig strømbryt
- evakuering
- psykiske kriser
- svikt i telefonnett eller samband
- smittespredning

Å dimensjonere helsetjenesten for å kunne håndtere alle disse hendelsene alene ville kreve uforholdsmessig store ressurser for en kommune på Smølas størrelse. Ved større kriser og katastrofer er Smøla derfor avhengig av støtte fra andre aktører, inkludert andrelinjetjenesten.

Dårlig vintervær fører ofte til stengte veier og krevende båtforhold. Dette innebærer at helsetjenesten til tider må håndtere alvorlig skadde eller syke pasienter underveis i transport til sykehus, eller i påvente av tilgjengelig helikopter. Det er derfor avgjørende at kommunen, basert på tydelige beredskapsrutiner, utnytter alle tilgjengelige ressurser—både kommunale og frivillige.

Det viktigste i en krisesituasjon er rask mobilisering av ressurser og klart definerte ansvarsforhold. Rutiner og planer må derfor være enkle, presise og lett anvendelige, og ansvarsforholdene bør, så langt det lar seg gjøre, være de samme som ved ordinær drift.

Beredskapsplanen består av tre hoveddeler:

1. **Administrativ del** – beskriver lokal geografi, ressursgrunnlag, relevante lover og forskrifter, samt kommunikasjonsmuligheter.
2. **Operativ del** – beskriver samarbeidsrutiner, oppgavefordeling og omlegging av drift ved ulykker og katastrofer.
3. **Tiltakskort** – gir konkrete handlingsplaner for spesifikke hendelser og tilstander.

Det vedlegges også en oppdatert telefonliste for alle samarbeidende aktører.

1.1.3.regional og nasjonal helseberedskap

Kommunal helsemessig- og sosial beredskapsplan er en av flere underplan til kommunens overordnede beredskapsplan.

Samarbeid ved kriser over kommunalt nivå eller i krig er underordnet kommunens kriseledelse.

Overordnet tverretattlig samarbeid beskrives i [St.meld.nr. 5 \(2023-2024\) En motstandsdyktig helseberedskap – Fra Pandemi til krig i Europa. \(Styrket system for helseberedskapen, motstandsdyktig helseberedskap og risiko- og sårbarhetsområder\)](#)

1.2.Lovgrunnlaget

1.2.1. Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)

I loven som trådte i kraft 1. juli 2001, sist endret i 20.06.2025 med ikrafttredelse 01.01.2026, krever tverrfaglig og tverretattlig samordning av kommunenes kriseberedskap. I § 1-1 første ledd heter det: "Formålet med loven er å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid." Loven pålegger også alle virksomheter som er involvert i oppfølgingen etter kriser og ulykker, å lage beredskapsplaner, jfr. § 2-2.

1.2.2. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lovens § 3-2 gir kommunene ansvar for helse- og omsorgstjenester:

Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:

- a. Legevakt
- b. Heldøgns medisinske akuttberedskap
- c. Medisinsk nødmeldetjeneste

1.2.3. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)

Lovens § 16 (Beredskapsplan, hjelpeplikt og gjensidig bistand) gir kommunen slikt ansvar: Kommunen plikter å utarbeide en beredskapsplan for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen i samsvar med lov om helsemessig og sosial beredskap. Sosialberedskapsplanen skal samordnes med kommunens øvrige beredskapsplaner. Kommunen skal gi nødvendig hjelp under ulykker eller andre akutte situasjoner. Dersom forholdene tilsier det, skal kommunen yte bistand til andre kommuner ved ulykker og andre akutte situasjoner. Anmodning om bistand fremmes av den kommunen som har bistandsbehovet. Den kommunen som mottar bistand etter tredje ledd, skal yte kommunen som bidrar med hjelp, kompensasjon for utgiftene, med mindre noe annet er avtalt.

1.2.4. Akuttmedisinforskriften

Ny forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning med mer

§ 1 Formål Forskriften skal bidra til at befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Forskriften skal også bidra til at utstyr som inngår i helse- og omsorgstjenestens kommunikasjonsberedskap fungerer i et landsdekkende nett og sikrer prioritert informasjonsflyt både innenfor og mellom medisinske institusjoner, til mobile enheter og til samarbeidende etater. § 2 Virkeområde Forskriften regulerer kommunenes og de regionale helseforetakenes akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Dette omfatter kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste og tjenester som ytes av andre etter avtale med kommunen eller regionalt helseforetak.

1.2.5. Folkehelseloven

§ 1. Formål Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. § 28. Beredskap Kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har ansvar for nødvendige beredskapsforberedelser og for tiltak i beredskapssituasjoner, jf. helseberedskapsloven § 2-1. Kommunen plikter å utarbeide en beredskapsplan for sine oppgaver etter denne lovens kapittel 3, i samsvar med helseberedskapsloven. Helseberedskapsplanen skal samordnes med kommunens øvrige beredskapsplaner.

1.2.6. relevante Stortingsmeldinger

Meld. St. 5 (2023–2024) **En motstandsdyktig helseberedskap Fra pandemi til krig i Europa**

Meld. St. 9 (2023–2024) **Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027**

Meld. St. 23 (2024–2025) **Fornye, forsterke, forbedre Framtidens allmennlegetjenester og akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus**

1.3. Definisjoner og prinsipper

Planen omhandler hendelse(r) som setter mange menneskers liv og helse i umiddelbar fare og som ikke kan håndteres tilstrekkelig gjennom ordinære ansvars- og kommandoforhold. En slik situasjon vil kreve ressurser utover det som inngår i den kommunale helse- og sosialtjenestens daglige drift.

1.3.1 Viktige definisjoner

1.3.1.1. Ordinær situasjon

Behovet for innsats dekkes på nødvendig faglig nivå av de ressurser i området som umiddelbart kan aktiviseres (dvs. vakthavende personell med deres ordinære materiell).

1.3.1.2. Ekstraordinær situasjon

Behovet for innsats er større enn kapasiteten til de ressurser som umiddelbart kan aktiviseres, men lar seg løse innen nødvendig tid på akseptabelt faglig nivå ved forsterking av tilgjengelige ressurser.

1.3.1.3. Katastrofe

Behovet for innsats overgår de ressurser som er tilgjengelige innenfor nødvendig tid.

1.3.1.4. Krig eller krigsfare

Defineres av sentrale myndigheter.

1.3.1.5. Ulykker

Ulykker forstås som uventede og potensielt traumatiserende hendelser som kan ramme menneskers liv og helse, for eksempel transportulykker, brann, industriulykker eller dagliglivets alvorlige enkeltulykker.

1.3.1.6. Kriser

Kriser, eller krisesituasjoner, er dramatiske og potensielt traumatiserende hendelser som kan true eller svekke viktige funksjoner og verdier hos enkeltpersoner, familier eller lokalsamfunn, samt svekke deres muligheter til å utføre viktige og sentrale oppgaver på individ- og familienivå, så vel som i et samfunnsperspektiv. Det er store forskjeller på kriser. En krisesituasjons karakter vil være avhengig av:

- Omfanget og potensielle konsekvenser
- Hvor brått krisesituasjonen inntreffer og hvor raskt den utvikler seg
- Varigheten
- Hvor godt enkeltpersoner/familier er forberedt på krisesituasjonen
- Hvor godt samfunnet er forberedt på krisesituasjonen

1.3.1.7.Katastrofer

Med en katastrofe menes en uventet og potensielt traumatiserende hendelse der antall rammede personer med behandlingsbehov langt overskrider de tilgjengelige ressursene som finnes i nærområdet av katastrofen. En krise-/katastrofesituasjons karakter vil være avhengig av:

- Omfanget og potensielle konsekvenser
- Hvor brått krisesituasjonen inntreffer og hvor raskt den utvikler seg
- Varigheten
- Hvor godt enkeltpersoner/familier er forberedt på krisesituasjonen
- Hvor godt samfunnet er forberedt på krisesituasjonen

1.3.1.8.Melding

Enhver som mottar melding om ulykke/katastrofe skal sørge for å få svar på følgende spørsmål:

- Hvem varsler?
- Hva har hendt?
- Hvor er skadestedet?
- Antall skadde?
- Hvordan kan den som varsler kontaktes tilbake?
- Er politiet varslet? (112)
- Er AMK-sentralen varslet? (113)
- Er brannvesenet varslet? (110)

Strukturen HENSPE er en god rettesnor for meldingsgangen:

H= Hendelse: ulykke, trafikk, fly, båt, industri, skred, brann, PLIVO

E= Eksakt posisjon: adresse, oppmøtested, ankomst/avreise

N= Nivå: Begrenset, stort eller masseskade

S= Sikkerhet: mulige reelle farer, sikkerhet for involverte

P= Pasienten: ca. antall og omfang

E= Evakuering: effektiv evakueringskjede, rett pasient på rett plass til rett tid

NB! Sørg for varsling av 113, 112 eller 110 dersom dette ikke allerede er ivarettatt!

Alle ansatte i Smøla kommune må straks de får kjennskap til en krise og gjøre nødvendige tiltak for å begrense skaden

- Akutt informasjon gis til personer i alvorlig fare
- Ved større kriser/hendelser varsles kommunal kriseledelse
- Kriseledelsen vil da koordinere innkalling av ekstra kommunalt helsepersonell og omfordele andre kommunale ressurser ut fra behov
- Kriseledelsen vil videre være kontakten mot øvrige ressurser for koordinering

1.3.2. overordnede prinsipper

Følgende prinsipper legges til grunn i alt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

1.3.2.1. Ansvarsprinsippet

Den organisasjon som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, har også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære hendelser på området.

1.3.2.2. Likhetsprinsippet

Den organisasjon man opererer med under kriser, skal i utgangspunktet være mest mulig lik den organisasjon man har til daglig.

1.3.2.3. Nærhetsprinsippet

Kriser skal organisatorisk håndteres på lavest mulig nivå.

1.3.2.4. Samvirkeprinsippet

Myndigheter, virksomheter og etater har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

1.4. Sentrale aktører

AMK-sentralen, politiet eller brann vil normalt være de som først mottar melding om ulykke/katastrofe og vil holde løpende kontakt under aksjonen over nødnettet og i innsatsleders kommandoplass

AMK-sentralen 113 koordinerer helseressursene utenfor kommunen som ambulanse, redningsbil, spesialisthelsetjenester og luftambulanse/SAR Queen.

Politiets operasjonssentral 112 Politiet er innsatsleder og leder aksjonen på stedet, politiet er også de som beslutter evakuering. (ILKO). Politimesteren kan sette Lokal redningssentral (LRS) og leder denne

Brann 110 sentralen bistå med koordinering av lokale og tilkalling av ekstrakommunale mannskaper og tekniske hjelpemidler

Den interkommunale legevaktsentralen (LV-sentralen) 116 117 i Kristiansund vil som hovedregel kobles inn ved kriser og bistå med innkalling og varsling av kriseledelsen, samt bidra til nødvendig koordinering og styring av legevakttjenesten.

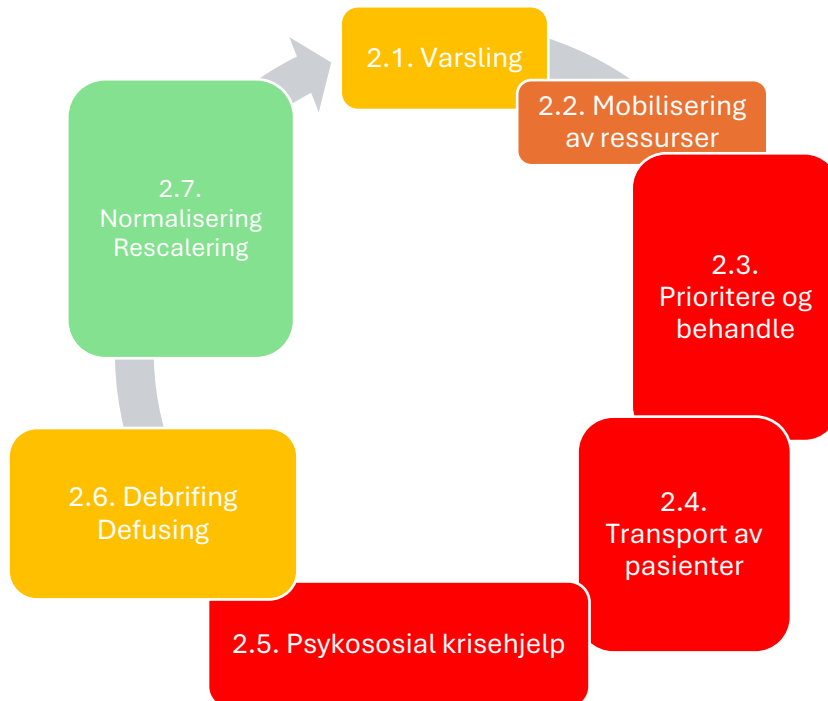
Lokale aktører:

- Legevakt

- Ambulanse
- Mørejenta (ambulansebåt)
- Sykeheimen
- Helsesenteret
- Evakuerte- og pårørendesenter (EPS)
- NAV – sosiale tjenester
 - NAV yter nødvendig bistand ved ulykker i henhold til lov om sosiale tjenester § 16.
 - NAV-leder, eller den som får delegert myndighet, har fullmakt til å innvilge økonomisk stønad etter § 19.

2. Operativ del

Hoved prosedyrer ved kriser



2.1. Varsling

Ved ulykker og kriser er det som oftest publikum som varsler legekontoret på dagtid, **LVS** (Legevaktsentralen) i Kristiansund eller **AMK** (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) i Ålesund. Hvis legekontoret eller LVS blir kontaktet først vedr. en større ulykke eller krise, skal alltid AMK varsles.

Vakthavende lege har ansvaret for å vurdere

- behovet for ev. trippelvarsling til andre nødetater/Politi, brann, Ambulanse) (via AMK) og
- ev. varsling til ordfører/rådmann ved kritiske hendelser, som da vurderer behovet for opprettelse av kriseledelse.
- behovet for utkalling av kriseteamet

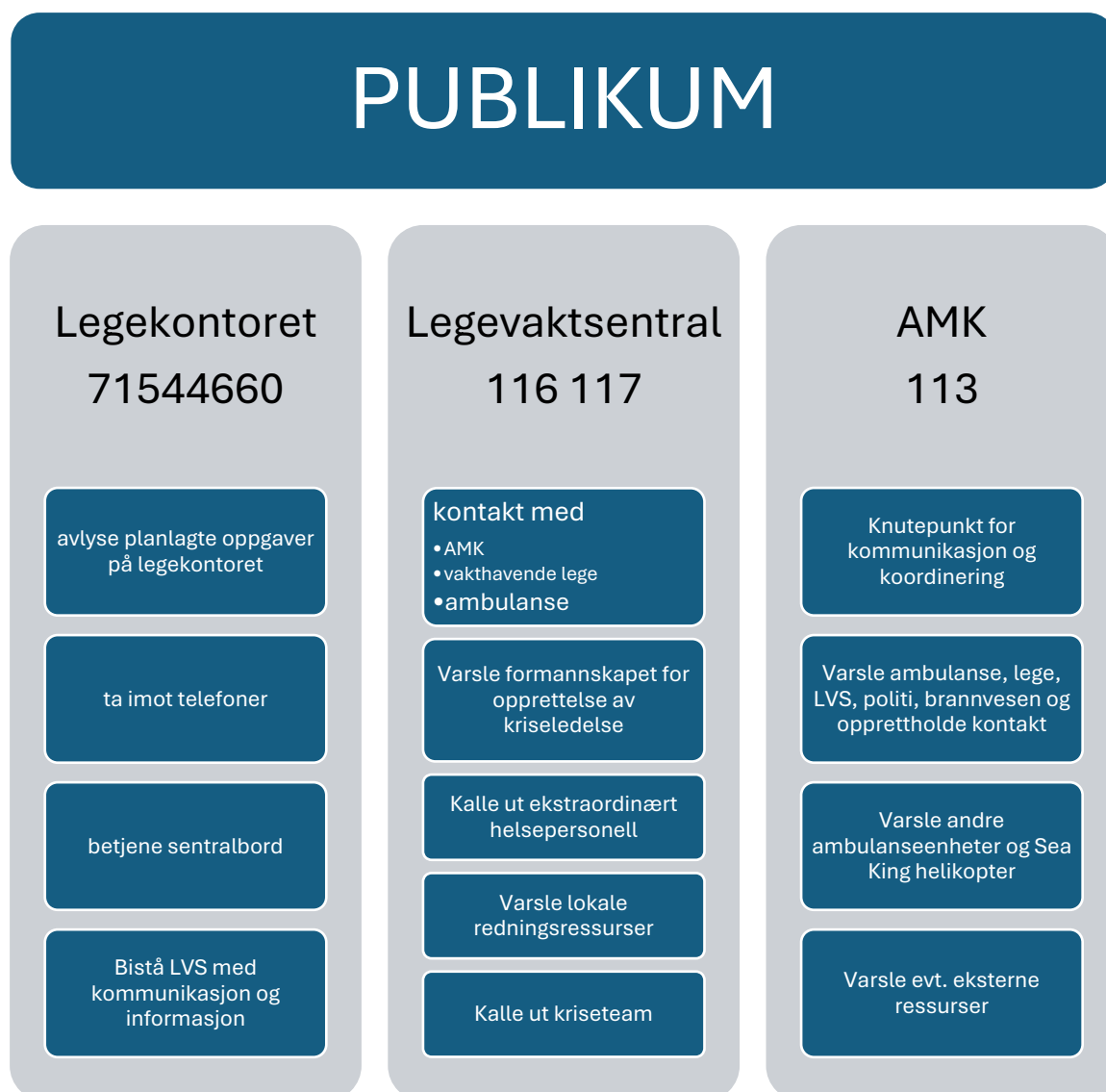
Etter ordre fra vakthavende lege varsler/utkaller AMK/LVS:

- ordfører
- kommunedirektør
- alle leger
- sykepleierne på vakt på sjukeheimen og i hjemmesykepleien

- avdelingssykepleiere
- annet helsepersonell
- ansatte ved legekantoret
- andre kommunale ressurser v/behov

Legekantoret (i åpningstid). Sekretær avlyser planlagt ordinært arbeid ved legekantoret og bistår LVS med deres oppgaver. Ansatte ved legekantoret bistår vakthavende lege.

2.1.1 Aktører ved varsling



2.2 Mobilisering av ressurser

Vakthavende lege har det medisinske ansvaret for beredskapsarbeidet. Vakthavende lege har også det administrative ansvaret for beredskapsarbeidet inntil evt. kommunal kriseledelse tar

over. Vakthavende lege bruker LVS og ansvarlig sykepleier til den praktiske gjennomføringen av administrasjonsarbeidet.

2.2.1. Utrykning

Ambulanse rykker ut til skadestedet etter varsling fra AMK/LVS. Vakthavende lege rykker ut i egen bil eller rekvirerer drosje, etter vanlig prosedyre. Hvis veien er stengt pga snø, må brøytebil varsles av vakthavende lege el. LVS.

LVS står for organiseringen av mer transport av personell og utstyr til skadestedet. AMK sender ut politi og brannvesen ved behov og vurderer også behovet for Sea-King helikopter, katastrofeteam fra sykehus, Sivilforsvaret, evt. andre eksterne ressurser.

2.2.2. Mørejenta

AMK varsler ambulansebåten. Om båten er ute i ambulanseoppdrag, må dette utføres så raskt som mulig, eller ev. avbrytes. Dette i samråd med LVS/AMK og vakthavende lege.

2.2.3. LVS og forberedelser på helsesenteret

Vakthavende sykepleier ved LVS har det administrative ansvaret for beredskapsarbeidet inntil evt. annen på Smøla overtar ansvaret. Dette avgjøres ut ifra omfang og varighet på beredskapsarbeidet.

2.2.4. Kommunikasjon

LVS/AMK blir det kommunale knutepunktet for kommunikasjon, og vakthavende sykepleier der har ansvaret. LVS/AMK varsler og koordinerer de lokale ressursene gjennom helseradionettet og annet telefonsamband. Ved større ulykker og kriser skal sentralbordet i resepsjonen ved legkontoret betjenes av 2 legesekretærer både i og etter ordinær arbeidstid. Hvis det ikke er mulig, skal sentralbordet betjenes av annet helsepersonell. Sentralbordet skal ta imot innkommende samtaler og avlyse planlagte oppgaver til vakthavende lege.

2.3. Prioritering og behandling

2.3.1 På skadestedet

Ansvaret for beredskapsarbeidet på skadestedet er fordelt mellom flere ledere:

Skadestedsleder (politi): Har som hovedoppgave å koordinere innsatsen til faglederne og legge forholdene best mulig til rette for at disse skal kunne utføre sine oppgaver; å redde mennesker fra død eller skade.

Fagleder Helse (vakthavende lege): Har det overordnede medisinske ansvaret for medisinsk personell og skal lede den medisinske behandlingen, herunder også foreta de nødvendige prioriteringer mht. behandling, personell og andre ressurser.

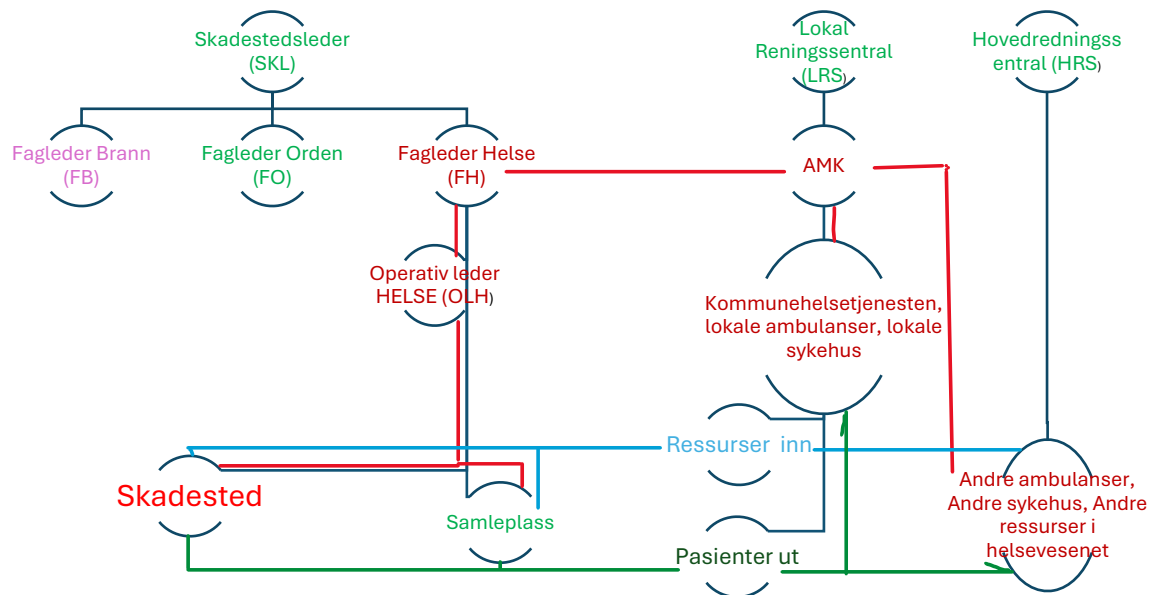
Operativ leder Helse (ambulansepersonell): Er underlagt fagleder helse og skal forestå organisering, ledelse og koordinering av det operative helseapparat.

Fagleder Brann (brannsjef eller stedfortreder): Har det faglige og operative ansvaret for Brannvesenets arbeid på skadestedet.

Fagleder Orden (politi): Skal ivareta alle funksjoner som gjelder orden, regulering og registrering samt tiltak som gjelder omkomne.

Lederne på skadestedet har vester på seg hvor det klart kommer fram hvilken funksjon de har på skadestedet. Dette er viktig da det fort blir uoversiktlig på et skadested.

Skadestedsleder oppretter kommandoplass, alt personell som kommer til skadestedet melder seg til skadestedsleder. Helsepersonell disponeres av Fagleder Helse.



Grafikk viser **informasjonsflyt** innenfor enhet helse, **Ressursflyt** og **pasientflyt**

2.3.2. Første helsepersonell som kommer til skadestedet

Hovedprinsipp 1: Ikke utsette seg selv eller andre for urimelig risiko

Hovedprinsipp 2: Forsøke å oppnå størst mulig grad av overlevelse, med minst mulig senkomplikasjoner

Er skadestedet sikret?

Skadestedet må sikres av brannvesen/politi før helsepersonell starter sitt arbeid.

Få oversikt!

Hvor mange skadede? Hva slags skader? Pasientene inndeles i følgende kategorier:

Haster: Pasienter med kritiske skader der sirkulasjon og respirasjon er truet.

Trenger raskt førstehjelp (sideleie, stanse store blødninger, mm.),

Transport og behandling.

Kan vente: Alvorlig skadede, men foreløpig stabile. Må overvåkes.

Må vente: Lett skadede. Dersom det er mange med alvorlige skader, vil meget

hardt skadde pasienter som det er små muligheter for å redde, tilhøre

denne gruppen.

Døde: Lege må bekrefte dødsfall. Skal ikke flyttes før politiet har tillatt

flytting til samle plass for døde. Skal ikke fraktes til sykestua.

Varsle AMK om situasjonen, om umiddelbart behov, samt antatt behov på sikt.

Prioritere oppgaver. Drive førstehjelp/akuttmedisinske tiltak. Sikre ABCDE:

A: Airways (frie luftveier)

B: Breathing (respirasjon)

C: Circulation (blodsirkulasjon, unngå sjokk)

D: Disability (Ustabil nakke/rygg? Unngå mer nerveskade)

E: Environment (miljø, unngå hypotermi)

På skadestedet utføres bare helt nødvendig førstehjelp som er påkrevd for å opprettholde livsviktige funksjoner. All annen behandling utføres på samle plass, hjelpe plass eller ved sykehus.

2.3.3. Samle plass og hjelpe plass

Fagleder helse og ambulansepersonell oppretter samle plass. De utser også eventuell hjelpe plass der skadede kan motta behandling og vente på transport til sykehus. Aktuelle hjelpe plasser er Smøla Helsesenter, Smøla Sjukeheim, skoler, rådhus og ungdomshus. Politiet oppretter evt. samle plass for døde.

2.4. Transport av pasienter

Fagleder helse vurderer i samarbeid med AMK om hvor og hvordan de enkelte pasientene skal sendes, basert på tilgjengelige ressurser og omfanget av skadene.

2.4.1. Mottak og behandling på helsesenter og sjukeheim

Vakthavende sykepleier har ansvaret for klargjøring til mottak av pasienter. Ved opptil tre skadede pasienter brukes helsesenteret til mottak som ved ordinær drift.

Hjelpepersonell/ansvarlig sykepleier sørger for at medisinsk utstyr er klargjort for bruk. Ved flere enn tre pasienter brukes Smøla Sjukeheim. Korridor ved hovedinngang og ev. tilgrensende oppholdsrom tas i bruk som samle plass. Ved mer enn 6 skadede, må det vurderes å evakuere avdeling for senil demente eller korttidsavdelingen for å kunne ta denne i bruk i sin helhet som samlingsplass.

Vakthavende sykepleier registrerer personalia og vakthavende lege vurderer pasientens tilstand og gir sykepleier informasjon om nødvendige tiltak før pasienten fraktes til anvist plass. Hvis det ikke er lege til stede, har ansvarlig sykepleier midlertidig ansvar for medisinsk behandling, veiledet av lege på skadestedet eller AMK/sykehuslege.

Oppegående beboere på sjukeheimen som er blitt evakuert flyttes til egnet stue på sjukeheimen eller oppholds stuen på omsorgsboliger for å frigjøre senge plasser. Dersom det er påkrevd og forsvarlig, kan pasienter utskrives fra sjukeheimen til hjemmet.

Nødvendig medisinsk utstyr bringes til sykehjemmet fra legekantoret og ev. fra Mørejenta.

Ved store ulykker med mange skadede, avgjør den kommunale kriseledelsen i samråd med Fagleder Helse om omsorgsboliger eller ECO Camp også skal benyttes som samlingsplass.

Enten i stedet for, eller i tillegg til helsesenteret og sjukeheimen. Det er gode muligheter for helikoptertrafikk ved helsesenteret på grusbanen ved ECO Camp.

Ved slik ulykke på Smølas nordlige og vestlige del, kan det også være aktuelt å ta i bruk andre lokaler som samlingsplass; skoler, samfunnshus eller rådhus.

Nødvendig utstyr må da fraktes dit. Det må være forsvarlige landingsforhold for helikopter.

Ved pandemi kan belegg på sykehjemmet kortvarig økes med 5 (22 + 5) slik at nye pasienter fra sykehus og egen kommune kan tas imot. Planlagte opphold ved sykehjemmet som kan vente forskyves.

I h.h.t lov om helsemessig og sosial beredskap, kan det i en beredskapssituasjon bli innført tjenesteplikt samt at arbeidstidsbestemmelsene kan bli suspendert

2.5.Pårørende og psykososial krisehjelp

Ved ordinær drift kontaktes pårørende av vakthavende lege eller den som han/hun utser. Ved ekstraordinær drift kontaktes pårørende av LVS. Det kommunale kriseteamet ta imot de pårørende på venterommet i helsesenteret. Helsestasjon og evtl møterom tas i bruk for videre behandling. Er krisen av et slikt omfang at kommunal kriseledelse er opprettet, skal kriseledelsens informasjonsavdeling informere pårørende og publikum.

Det kommunale kriseteamet skal utkalles til Smøla helsesenter og ta imot de pårørende som kommer dit. Kriseteamet registrerer hvem de pårørende er, gir dem psykososial krisehjelp og sørger for at de følges opp av kommunehelsetjenesten eller prest ved behov. Om nødvendig utkalles annet helsepersonell til å bistå kriseteamet med dette arbeid.

2.6.Debriefing/normalisering

Når det akutte beredskapsarbeidet er avsluttet, er det viktig å sørge for debriefing for alle som har deltatt i arbeidet. Debriefing skal helst finne sted umiddelbart etter at krisearbeidet er sluttført, med mindre særskilte grunner tilsier noe annet. Vakthavende lege, sykepleier som har deltatt i arbeid eller psykiatrisk sykepleier innkaller til debriefing. Debriefing ledes fortrinnsvis av kriseteamets leder eller medlem av kriseteamet med erfaring i debriefingsarbeid.

3.Tiltakskort

Dette kapittelet beskriver operative og veiledende tiltak for helsemessig og sosial beredskap i Smøla kommune. Tiltakene er strukturert for både vakthavende personell og støttepersonell, med tydelige ansvars- og varslingslinjer. Dokumentet refererer til gjeldende lover, forskrifter og kommunale planer.

3.1.Brann – helsesenter / sykeheim

Bakgrunn: Risiko for brann kan true liv, helse og materielle verdier. Evakuering må skje umiddelbart.

Ansvar: Vakthavende sykepleier / vakthavende lege

Tiltak:

1. Varsle avdelingsleder og vakthavende lege
2. Aktivere branninstruks og organisere redningsarbeid
3. Evakuere pasienter til ECO Camp eller omsorgsboliger
4. Opprette provisoriske medisinske behandlingsplasser
5. Kommunikasjon via mobil og nødnett

Ressurser: Ambulanse, drosje, kommunale kjøretøy, MØREJENTA som backup kontor

Risikovurdering: Brann kan spre seg raskt; pasienter med redusert mobilitet krever prioritet.

Dokumentasjon/rapportering: Brannrapport, logg i P360, varslingslinje til kommuneledelse

3.2.Brann – omsorgsboliger / Hopen bofellesskap

Bakgrunn: Lik 3.1, men evakuering midlertidig til sykehjemmet.

Ansvar: Vakthavende sykepleier / vakthavende lege

Tiltak: Som 3.1, med midlertidig evakueringssted = sykehjemmet

Ressurser: Som 3.1

Risiko: Som 3.1

3.3.Evakuering

Ansvar: Kommunal kriseledelse

Tiltak:

1. Evakuere personer fra skadeområde til trygt område

2. Koordinere transport og innkvartering
3. Samarbeid med brann, politi og helse

Risiko: Manglende transportkapasitet, personer med medisinske behov

Dokumentasjon: Evakueringslogg, rapportering til kriseledelse

3.4.CBRNE – kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktivitet og smittestoffer

Ansvar: Vakthavende lege / CBRNE-senter / Giftsentralen

Tiltak:

- Kjemiske stoffer: Rådfør med Giftsentralen, sikre og sanere skadested
- Radioaktiv stråling: Sanering som ammoniakkutslipp, distribuer Jod-tabletter (medisinrommet på legekantor)
- Smittestoffer: Følg kommunal smittevernplan

Ressurser: PPE, desinfeksjon, AMK/LVS, saneringsutstyr

Risiko: Helsefare ved direkte eksponering, sekundærkontaminering

3.5.Amonniakkutslipp

Ansvar: Vakthavende lege / brann / politi

Tiltak:

1. Sikre skadested
2. Helsepersonell går ikke inn før sanering
3. Pasienter skylls rikelig før førstehjelp

Ressurser: PPE, nøytralisering, ambulanse

Risiko: Alvorlige luftveis- og hudskader

3.6.Mobil/internett/nødsamband feil

Ansvar: Vakthavende lege / formannskap

Tiltak:

1. LVS/AMK kontaktes via nødsamband
2. Varsle helsesenter og hjemmesykepleie
3. Hjemmebesøk ved trygghetsalarm-brukere
4. Midlertidig institusjon/familie for kritiske brukere

Ressurser: Iridiumtelefoner, manuelle rutiner

Risiko: Kritiske helsetjenester kan bli forsinket

3.7.Strømstans

Ansvar: Enhetsleder helse / vakthavende lege

Tiltak:

1. Aktivere nødstrømsaggregat
2. Sørge for strøm til medisinsk utstyr
3. Økt beredskap for hjemmebehandling med strømvhengig medisinsk utstyr
4. Nød-PC / Helseplattformen benyttes

Risiko: Avbrudd i livsnødvendig behandling

Utfyllende kommentarer: Ved feil på 4/5Gnettet, blir vakthavende lege og ambulansetjenesten kontaktet av LVS/AMK via nødsambandet. Sannsynligheten for at både mobiltelefonnettet og nødsambandet er nede samtidig, er minimal. Et relevant problem er at trygghetsalarmene kan slutte å fungere ved feil på nettet. Det medfører også problem for publikum som ikke får ringt til LVS ved akutte hendelser. Det er besluttet innkjøp og drift av Iridiumtelefoner jfr. handlings- og økonomiplan 2025 -2028.

Ved feil på mobiltelefonnettet skal den instans som først får vite om feilen ta kontakt med formannskapet. Hvis formannskapet ikke kan kontaktes, kontaktes vakthavende lege. Formannskapet eller vakthavende lege varsler LVS, helsesenter og hjemmesykepleien for økt beredskap. Hjemmesykepleien må prøve å etablere kontakt med primærkontaktene til brukere av trygghetsalarm samt regelmessig og hyppig rykke ut på hjemmebesøk til brukere av trygghetsalarm for å se at alt er i orden inntil feilen i telefonnettet er rettet. Ved langvarig feil, eller ved stor sannsynlighet for forverring av sykdom, må det vurderes om brukeren midlertidig bør oppholde seg hos familie/slektninger, eller på institusjon med heldøgns tilsyn.

3.8.Psykisk krise

Ansvar: Kriseteam (kommuneoverlege, sosionom, helsesøster, BV-leder, enhetsleder omsorg, sogneprest)

Tiltak:

1. Aktivere kriseteam
2. Gi akutt psykososial støtte
3. Formidle videre oppfølging

Risiko: Påkjenning for pasienter, pårørende og personell

Utfyllende kommentarer: Kriseteamet skal fungere i den akutte fasen. Det vil si i kriser, når de er der, og være videreformidler til det øvrige hjelpeapparatet for videre oppfølging. Kriseteamet settes inn når *flere personer* rammes i forbindelse med:

- Ulykke som medfører fare for tap av menneskeliv
- Plutselig og uventet dødsfall
- Ulykker med store menneskelige skader
- Selvmordsfare, selvmordsforsøk eller gjennomført selvmord
- Ulykker der faren for egne liv (innsatspersonellet) har vært stor

Kriseteamet er basert på frivillighet og har ingen reell vaktfunksjon. Det betyr at i ferie og høytider kan flere av medlemmene i kriseteamet være utilgjengelige. Ved akutt krise i legevaktsammenheng, vurderes behovet for at kriseteamet skal kontaktes.

Vakhavende lege kontakter teamet via AMK, som da informere leder av kriseteamet (eller stedfortreder) for å kontakte tilgjengelige medlemmer.

3.9. Ekstremvær

Ansvar: Kriseledelse

Tiltak:

1. Aktivere kriseledelse
2. Opprettholde høy beredskap
3. Tiltak tilpasses konkrete hendelser

Ressurser: Kommunal kriseplan, helse- og tekniske ressurser

Utfyllende kommentarer: Smøla kommune ligger værutsatt til. Ved ekstremvær kan flere av hendelsene som nevnt i pkt. 3.8, inntre. Skulle ulykken være ute, har kommunen plan for rutiner ved ekstremvær. Ved slik hendelse opprettes kommunal kriseledelse og kommunehelsetjenesten opprettholder høy beredskap. Tiltak er avhengig av hvilke hendelser som oppstår i forbindelse med ekstremværet.

3.10. Smittespredning

Ansvar: Vakhavende lege / smittevernlege

Tiltak:

1. Varsle smittevernlege
2. Isolere pasienter
3. Følg kommunal smittevernplan

Ressurser: sykeheim, isolat

Utfyllende kommentarer: Ved fare for smittespredning av allmennfarlig sykdom kontakter vakthavende lege smittevernlege. Ved akutt fare for smittespredning i vakttid er vakthavende lege stedfortreder for smittevernlege. Ved behov for isolering kan egnet avdeling ved sjukeheimen evakueres for pasienter og brukes som isolat. Det vises ellers til kommunal smittevernplan som ligger som vedlegg til beredskapsplanen.

3.11.Pandemi

Ansvar: Vakthavende lege / smittevernlege

Tiltak: Følg Smittevern- og Pandemiplan

Ressurser: Kommunikasjonsrutiner, smittevernutstyr

3.12.Sosial beredskap

Ansvar: NAV-leder

Tiltak:

1. Yte midler for livsopphold
2. sikre tilstrekkelig bemanning
3. Ivareta barn/ungdom via barnevern

Risiko: Kritiske behov hos utsatte grupper

Utfyllende kommentarer: Sosial beredskap skal ved kriser, både i fredstid og krig, best mulig opprettholde befolkningens velferd ved å yte midler til livsopphold og gi informasjon til de som trenger det.

NAV har i forhold til sosial beredskap som oppgave å sikre beredskapen på to områder:

1. Ha en god intern beredskap for å sikre tilstrekkelig bemanning for å ivareta oppgaver knyttet til inntektssikring av livsoppholdsytelser.
2. Sikre arbeidskraftbehovet til samfunnsviktige virksomhetsbedrifter. Ved betydelig fravær i arbeidsstyrken kan det oppstå et stort press for å framskaffe arbeidskraft både for NAV-kontorene og andre arbeidsformidlerer.

Utbetaling av trygdeytelser er helt avhengig av at de elektroniske kommunikasjonslinjene fungerer og at postens og bankens betalingssystemer fungerer.

Dersom så ikke skjer, må vi ha en kommunal beredskap i forhold til utbetaling ved NAV-kontoret. Det må da ordnes med mulighet for manuell rekvisisjon eller utbetaling via økonomikontoret på rådhuset.

Det kan være aktuelt å få kontant utbetaling via sentrale myndigheter evt. Statsforvalter, dersom all betalingsformidling bryter sammen. I krig vil vi kunne benytte oss av Statsforvalterens adgang til å rekvirere penger. Postverket og bankene er imidlertid helt sentrale aktører for å få tak i kontante penger. Banken forutsettes å ha utarbeidet plan for å håndtere ulike pengekriser.

Ved ulykker/katastrofer der barn/ungdommer er berørt, skal NAV-leder/leder av barnevernstjenesten vurdere situasjonen og sette inn hjelpetiltak eller foreta en plassering på egnet sted under trygge forhold.

Barn kan eventuelt bli berørt ved at omsorgsperson for kortere eller lengre tid kan bli ute av stand til å ivareta sine oppgaver, som en konsekvens av ulykke/katastrofe.

Barnevernet skal ivareta barn og unges rett til omsorg.

I h.h.t lov om helsemessig og sosial beredskap, kan det bli innført tjenesteplikt samt at arbeidstidsbestemmelsene kan bli suspendert. Utvidelse av kapasiteten ved NAV-kontoret vil skje etter følgende regler og i prioritert rekkefølge:

1. Ansatte i deltidstillinger går over i heltidstillinger
2. Arbeidstiden utvides til 12 timer pr døgn
3. Støttekontakter/besøkshjem som er tilknyttet sosial- og barnevernstjenesten kan bli tatt inn i tjenesten midlertidig.

Meldested for sosiale tjenester: NAV Smøla, Rådhuset, Hopen.

NAV-leder sørger for at det etableres betjening på døgnbasis og innkaller personell i prioritert rekkefølge etter vurdering av behovet.

Det vises også til lokal beredskapsplan for NAV Smøla utarbeidet etter etablering av lokalt NAV-kontor.

3.13.Kriseledelse

Ansvar: enhver ansatt som blir bekjent med tilstander, som kan medføre kriser skal varsle sin overordnede.

Tiltak:

1. Aktivere kriseledelse
2. Koordinere tiltak tverretattlig
3. Varsling og rapportering

Utfyllende kommentarer: Ekstraordinære situasjoner krever koordinerte tiltak fra flere aktører. Forhold med betydning for liv og helse oppstår under tilnærmet alle ekstraordinære situasjoner. For å etterleve kommunens ansvar for vern av befolkningens liv og helse er det etablert kriseledelse ved truende situasjoner med fare for at ekstraordinære situasjoner kan oppstå eller når ekstraordinære situasjoner har oppstått.

Varslings- konstituerings og samarbeidsrutiner er beskrevet i Smøla kommunes overordnede beredskapsplan (P360 saksdokument 21/000-30), vedleggene inneholder varslingslister, ressursoversikt og tiltakskort

3.14.Kompetanse, opplæring og øvelser

Ansvar: Enhetsleder / HR

Tiltak:

1. Jevnlig opplæring
2. Årlig praktisk / tverretatlig øvelse
3. Dokumentasjon og rapportering

Utfyllende kommentarer: I [Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap](#), stilles det i § 7 krav til kompetanse, opplæring og øvelser.

Smøla kommune har ansvar for å gi de av sine ansatte som vil inngå i beredskapsplanen, jevnlig opplæring og trening i sin rolle under ulike typer kriser og katastrofer. Øvelser er et viktig element i kvalitetssikringen for å bedre håndteringen som en normalt ikke får trening i. Det finnes ulike øvingsformer, fra enkle varslingsøvelser, via såkalte ”bordøvelser” til praktiske øvelser. For å ivareta kompetansekravet skal det avholdes en praktisk/tverretatlig øvelse i året.

3.15.Evaluering

Ansvar: kommunedirektør/kommunalsjefer/ enhetsledere

Tiltak:

1. Evaluere øvelser og reelle hendelser
2. Kvalitetssikre planverk
3. Kommunestyret evaluerer hvert 3. år

Utfyllende kommentarer: Etter hver øvelse skal det gjennomføres en evaluering for på den måten å kunne kvalitetssikre planverkene. Plan for helsemessig og sosialberedskap skal evalueres hvert 3. år av kommunestyret. Ansvar for evalueringen tillegges rådgivere i samarbeid med berørte enhetsledere.
